



SIMULADO INTEGRADOR P2

Medicina - estilo de cobrança AFYA | 20 questões objetivas | nível aumentado

Aluno(a):	_____
Turma:	_____ Data: ____/____/____
Orientação:	Assinale apenas uma alternativa por questão.

Este simulado foi construído para treinar raciocínio integrado, identificação de pegadinhas conceituais e domínio fino de morfofisiologia, semiologia, epidemiologia, saúde coletiva e ética em pesquisa.

Questões

Leia cada enunciado com atenção. As alternativas foram construídas com distratores próximos para exigir domínio conceitual e raciocínio integrado.

1ª QUESTÃO

Enunciado:

Durante visita domiciliar em área que sofreu alagamento recente, a ACS identifica um homem de 32 anos com febre alta, mialgia intensa em panturrilhas, cefaleia, hiperemia conjuntival e icterícia discreta. O paciente relata contato com água de enchente há cinco dias. Ao considerar a suspeita clínica e a conduta de vigilância em saúde, a equipe deve:

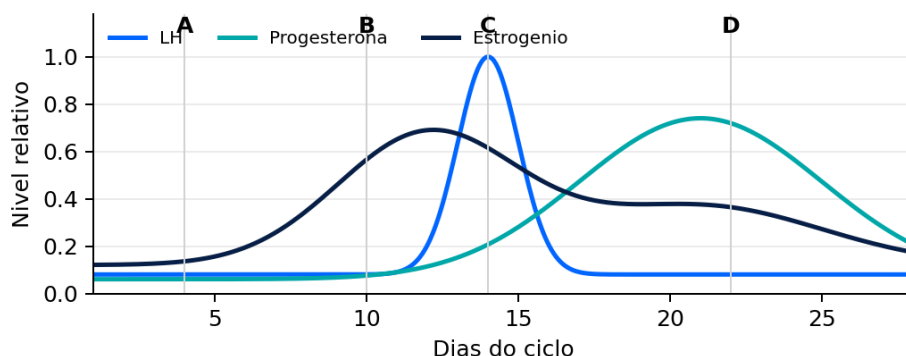
Alternativas:

- A) notificar compulsoriamente o caso suspeito no SINAN, iniciar investigação epidemiológica e orientar medidas de prevenção sem aguardar confirmação laboratorial.
- B) registrar apenas como atendimento individual na APS, pois a notificação só ocorre após cultura positiva.
- C) encaminhar para sorologia e notificar apenas se houver insuficiência renal ou hemorragia pulmonar.
- D) realizar notificação somente ao serviço de zoonoses local, pois não se trata de agravo de interesse epidemiológico nacional.

2ª QUESTÃO

Enunciado:

Mulher de 27 anos, nuligesta, apresenta ciclos regulares de 28 dias. Em uma avaliação, observa-se muco cervical filante e, dias depois, biópsia endometrial com glândulas tortuosas, secreção no lúmen e estroma edemaciado. O gráfico abaixo representa, de modo esquemático, a variação hormonal ao longo do ciclo. A fase mais compatível com o padrão histológico descrito é:



Alternativas:

- A) região A, correspondente à fase menstrual, com predomínio da queda hormonal e descamação funcional.
- B) região B, correspondente à fase proliferativa inicial, dependente principalmente de estrogênio.
- C) região C, correspondente ao pico ovulatório de LH, antes da ação secretora da progesterona.
- D) região D, correspondente à fase secretora/lútea, dependente de progesterona do corpo lúteo.

3ª QUESTÃO

Enunciado:

Em lâmina histológica da região cervical anterior, um estudante observa folículos preenchidos por coloide e, nas proximidades, células pálidas agrupadas entre os folículos. Em outro corte, observa cordões celulares de uma glândula associada ao metabolismo do cálcio. A associação correta entre célula e produto hormonal é:

Alternativas:

- A) células foliculares: T3 e T4; células parafoliculares: calcitonina; células principais da paratireoide: PTH.
 B) células foliculares: calcitonina; células parafoliculares: TSH; células principais da paratireoide: tiroglobulina.
 C) células foliculares: PTH; células parafoliculares: T3 e T4; células principais da paratireoide: calcitonina.
 D) células oxífilas: principal fonte de PTH no adulto jovem; células foliculares: aldosterona; células parafoliculares: cortisol.

4ª QUESTÃO

Enunciado:

Após estudo sobre fatores associados a pior autopercepção de saúde em adultos de uma comunidade, obteve-se a tabela abaixo:

Fator associado	OR	Intervalo de 95% CI	p-valor
Sedentarismo	1,80	1,10-2,95	0,018
Consumo regular de vegetais	0,62	0,41-0,95	0,027
Baixa renda	1,20	0,88-1,63	0,242
Tabagismo	2,40	1,05-5,50	0,039

Analise as asserções a seguir.

I. Sedentarismo e tabagismo apresentaram associação positiva estatisticamente significativa com pior autopercepção de saúde, enquanto consumo regular de vegetais apresentou associação protetora; baixa renda, nessa tabela, não apresentou associação estatisticamente significativa.

PORQUE

II. Em regressão logística, OR maior que 1 indica aumento das odds do desfecho, OR menor que 1 indica redução das odds, e a significância estatística deve considerar o intervalo de confiança e/ou o p-valor.

Alternativas:

- A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
 B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
 C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
 D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

5ª QUESTÃO

Enunciado:

Paciente com queimadura térmica superficial extensa evolui com dor e perda aumentada de água pela superfície corporal. Considerando as funções e a organização histológica do tegumento, assinale a alternativa correta:

Alternativas:

- A) A epiderme é vascularizada e seu sangramento explica a perda hídrica das queimaduras superficiais.
- B) A epiderme é epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, avascular, com papel de barreira; na pele espessa há estrato lúcido.
- C) A hipoderme corresponde a uma camada epidérmica rica em melanócitos e queratinócitos em mitose.
- D) Glândulas sebáceas e sudoríparas são endócrinas, pois lançam suas secreções diretamente na corrente sanguínea.

6ª QUESTÃO

Enunciado:

Homem de 58 anos, hipertenso, apresenta cefaleia progressiva, vômitos em jato e borramento visual. Ao exame de fundo de olho, observa-se apagamento das margens do disco óptico bilateralmente. Analise as asserções.

I. O achado descrito é compatível com papiledema e sugere aumento da pressão intracraniana.

PORQUE

II. O nervo óptico é envolvido por bainhas meníngeas, e o espaço subaracnóideo ao seu redor comunica-se com o compartimento intracraniano, permitindo transmissão do aumento pressórico.

Alternativas:

- A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

7ª QUESTÃO

Enunciado:

No exame admissional, trabalhador de 45 anos relata vertigem rotatória, náuseas e piora ao movimentar a cabeça. Na prova de Romberg, permanece estável com os olhos abertos, mas cai para a direita ao fechar os olhos. Há nistagmo horizontal. A alteração mais provável é de origem:

Alternativas:

- A) vestibular direita, pois a perda assimétrica de informação labiríntica pode desviar a postura para o lado hipofuncionante.
- B) cerebelar esquerda, pois a marcha atáxica cerebelar desaparece ao abrir os olhos.
- C) visual direita, pois a queda no Romberg indica lesão primária do nervo óptico ipsilateral.
- D) motora piramidal, pois a síndrome do neurônio motor superior cursa com vertigem rotatória e nistagmo.

8ª QUESTÃO

Enunciado:

Mulher de 51 anos, obesa, procura a UBS com poliúria, polidipsia e perda ponderal discreta. Exame casual realizado durante a consulta mostra glicemia de 228 mg/dL. A hemoglobina glicada retorna em 6,7%. Não há cetonemia, vômitos ou rebaixamento do nível de consciência. Diante dos critérios diagnósticos, conclui-se que:

Alternativas:

- A) não é possível diagnosticar diabetes, pois todo diagnóstico exige duas glicemias de jejum alteradas.
- B) o quadro define diabetes tipo 1, pois a presença de sintomas sempre indica deficiência absoluta de insulina.
- C) o diabetes pode ser diagnosticado pela glicemia casual maior ou igual a 200 mg/dL associada a sintomas clássicos, reforçado pela HbA1c maior ou igual a 6,5%.
- D) trata-se de pré-diabetes, pois a hemoglobina glicada só confirma diabetes quando ultrapassa 7,0%.

9ª QUESTÃO

Enunciado:

As glândulas suprarrenais possuem córtex organizado em zonas e medula de origem embriológica distinta. Analise as afirmativas:

- I. A zona glomerulosa produz aldosterona, regulada principalmente pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona e pela concentração de potássio.
- II. A zona fasciculada produz cortisol sob influência do ACTH, favorecendo gliconeogênese e mobilização de substratos energéticos.
- III. A medula suprarrenal deriva do mesoderma intermediário e secreta principalmente hormônios esteroides.
- IV. A zona reticular é a principal produtora de mineralocorticoides e responde diretamente ao TSH.

Alternativas:

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e IV apenas.
- D) III e IV apenas.

10ª QUESTÃO

Enunciado:

Considere um esquema simplificado da orelha com as seguintes estruturas numeradas:

Número no esquema	Estrutura representada
1	Membrana timpânica
2	Cadeia ossicular
3	Cóclea
4	Nervo vestibulococlear
5	Tuba auditiva

A partir da relação entre as estruturas e os tipos de perda auditiva, assinale a alternativa correta:

Alternativas:

- A) A obstrução da tuba auditiva causa perda neurossensorial pura por destruição direta das células ciliadas da cóclea.
- B) A fixação do estribo na cadeia ossicular causa perda auditiva condutiva; lesões cocleares ou do nervo vestibulococlear tendem a causar perda neurossensorial.
- C) A perfuração da membrana timpânica preserva integralmente a condução aérea e, por isso, não altera a audiometria.
- D) Lesões do nervo vestibulococlear são classificadas como perdas condutivas por acometerem estruturas da orelha média.

11ª QUESTÃO

Enunciado:

A lesão do manguito rotador pode gerar dor e limitação funcional do ombro, especialmente em movimentos acima da cabeça. Sobre os músculos envolvidos, analise as afirmativas:

- I. O supraespal participa do início da abdução e contribui para estabilizar a cabeça do úmero na cavidade glenoidal.
- II. Infraespal e redondo menor atuam na rotação lateral; o subescapular atua na rotação medial.
- III. A cabeça longa do bíceps é um dos quatro músculos que compõem formalmente o manguito rotador.
- IV. O subescapular é innervado pelo nervo supraespal e é o principal rotador lateral do ombro.

Alternativas:

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e IV apenas.
- D) III e IV apenas.

12ª QUESTÃO

Enunciado:

Paciente de 59 anos com diabetes tipo 2 comparece à ESF dizendo que "a glicose está normal", pois a glicemia de jejum do dia foi 96 mg/dL. No entanto, a HbA1c solicitada no acompanhamento retornou em 8,4%. Considerando o significado fisiopatológico da HbA1c e o cuidado longitudinal, a melhor interpretação é:

Alternativas:

- A) a HbA1c reflete a exposição glicêmica média das últimas semanas, especialmente 2 a 3 meses, e pode revelar hiperglicemia sustentada mesmo com jejum isolado normal.
- B) a glicemia de jejum normal invalida a HbA1c, que só tem utilidade para diagnosticar anemia.
- C) o resultado indica remissão do diabetes, pois a HbA1c sempre muda no mesmo dia da glicemia capilar.
- D) o controle está adequado, pois em diabetes tipo 2 a HbA1c só deve preocupar quando ultrapassa 10%.

13ª QUESTÃO

Enunciado:

Homem de 66 anos procura atendimento por noctúria, jato urinário fraco e sensação de esvaziamento incompleto. O médico decide realizar toque retal como parte da avaliação. Sobre a técnica e os achados avaliados, assinale a alternativa correta:

Alternativas:

- A) A próstata é palpada na parede posterior do reto, e as vesículas seminais são sempre alcançadas até o fundo de saco retal.
- B) O exame deve ser feito sem lubrificação, pois o lubrificante impede a avaliação da sensibilidade e da mobilidade da próstata.
- C) Deve-se inspecionar a região perianal e, ao exame digital, avaliar paredes retais e a próstata na parede anterior quanto a tamanho, consistência, sulco, mobilidade, dor e nódulos.
- D) O PSA substitui completamente o toque retal em paciente sintomático, tornando desnecessária a avaliação física da próstata.

14ª QUESTÃO

Enunciado:

Mulher de 38 anos usa glicocorticoide sistêmico há 7 meses para doença autoimune. Evoluiu com aumento de peso, face arredondada, estrias violáceas, hipertensão, hiperglicemia e fraqueza muscular proximal. A alternativa que melhor explica esse conjunto de achados é:

Alternativas:

- A) glicocorticoides reduzem a gliconeogênese e promovem anabolismo muscular, gerando hipoglicemia e hipertrofia.
- B) o ganho de peso ocorre exclusivamente por aumento de glicogênio hepático, sem relação com redistribuição de gordura ou apetite.
- C) cortisol e aldosterona são quimicamente idênticos e atuam apenas em receptores renais de mineralocorticoides.
- D) o uso crônico pode causar redistribuição de gordura, hiperglicemia, catabolismo proteico, pele fina, osteopenia/osteoporose e supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.

15ª QUESTÃO

Enunciado:

A Secretaria Municipal de Saúde analisou os dados anuais de hipertensão arterial no município:

Indicador de hipertensão	Valor
População do município	50.000 habitantes
Casos existentes em 1º de janeiro	8.500
Casos novos durante o ano	500
Óbitos/migração entre hipertensos	100
Casos existentes em 31 de dezembro	8.900

Usando os dados apresentados, assinale a alternativa correta:

Alternativas:

- A) A prevalência ao final do ano foi de aproximadamente 1,0%, pois deve considerar apenas os casos novos.
- B) A prevalência ao final do ano foi de 17,8%, e a incidência acumulada aproximada na população inicialmente em risco foi cerca de 1,2%.
- C) A incidência foi nula, pois hipertensão é uma condição crônica e não pode gerar casos novos.
- D) A prevalência ao final do ano foi de 10%, e a incidência acumulada foi obrigatoriamente 17,8%.

16ª QUESTÃO

Enunciado:

Pesquisadores planejam ensaio clínico randomizado para comparar duas estratégias terapêuticas em uma condição crônica. Parte dos participantes será recrutada em serviço público de saúde, e alguns convidados podem ter baixa escolaridade. Sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinale a alternativa correta:

Alternativas:

- A) O TCLE pode ser dispensado sempre que a pesquisa não envolver cirurgia ou coleta de sangue.
- B) O consentimento deve ser obtido preferencialmente após a randomização, para evitar viés de seleção.
- C) A participação pode ser condicionada ao recebimento de medicamentos de rotina, desde que o estudo tenha potencial benefício social.
- D) O TCLE deve ser prévio, claro, voluntário, informar riscos, benefícios, confidencialidade e direito de retirada; quando aplicável, menores exigem consentimento do responsável e assentimento.

17ª QUESTÃO

Enunciado:

Durante ação educativa na sala de espera da UBS, uma mãe pergunta como agir em caso de obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Considerando suporte básico de vida, assinale a orientação correta:

Alternativas:

- A) Em lactente consciente com obstrução grave, alternam-se cinco golpes nas costas e cinco compressões torácicas; em criança maior/adulto consciente com tosse ineficaz, indicam-se compressões abdominais.
- B) Em qualquer idade, deve-se realizar varredura digital às cegas na boca antes de iniciar manobras.
- C) A oferta de água deve ser a primeira conduta em adulto com cianose e incapacidade de tossir.
- D) Em lactentes menores de 1 ano, a manobra abdominal é preferível às compressões torácicas, pois reduz risco de lesão.

18ª QUESTÃO

Enunciado:

Homem de 72 anos, destro, é levado ao pronto atendimento por início súbito de fraqueza em face e membro superior direitos. Está consciente, compreende ordens simples, mas fala com grande esforço, frases curtas e articulação prejudicada. A topografia cortical mais compatível com o distúrbio de linguagem é:

Alternativas:

- A) área de Wernicke no giro temporal superior dominante, responsável por afasia não fluente com compreensão preservada.
- B) cerebelo direito, responsável por afasia motora e paresia facial central.
- C) área de Broca no giro frontal inferior do hemisfério dominante, associada à afasia não fluente e relativa preservação da compreensão.
- D) córtex occipital esquerdo, responsável pela produção motora da fala e pela força do membro superior.

19ª QUESTÃO**Enunciado:**

Pessoas com deficiência visual podem realizar leitura tátil por Braille, que depende de mecanorreceptores cutâneos especializados na pele glabra dos dedos. Sobre a transdução sensorial tátil, assinale a alternativa correta:

Alternativas:

- A) Corpúsculos de Pacini detectam pressão estática fina, enquanto corpúsculos de Meissner detectam exclusivamente dor térmica.
- B) Discos de Merkel codificam pressão sustentada e bordas; corpúsculos de Meissner participam do tato leve/flutter; Pacini detecta vibração de alta frequência; Ruffini detecta estiramento cutâneo.
- C) Nociceptores encapsulados são os principais responsáveis pela discriminação espacial fina do Braille.
- D) Fusos musculares estão localizados na epiderme e são os receptores primários de textura na polpa digital.

20ª QUESTÃO**Enunciado:**

Paciente de 44 anos apresenta fadiga, intolerância ao frio, constipação, pele seca e ganho ponderal. Exames mostram TSH elevado, T4 livre reduzido e anti-TPO positivo. Considerando o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, a interpretação mais adequada é:

Alternativas:

- A) hipotireoidismo central, pois a hipófise não consegue elevar o TSH diante da queda do T4.
- B) hipertireoidismo subclínico, pois TSH alto e T4 baixo indicam excesso de hormônio tireoidiano.
- C) a elevação do TSH decorre de aumento do feedback negativo exercido pelo T4 livre elevado.
- D) hipotireoidismo primário, em que a falência tireoidiana reduz T4, diminui o feedback negativo e eleva TSH.